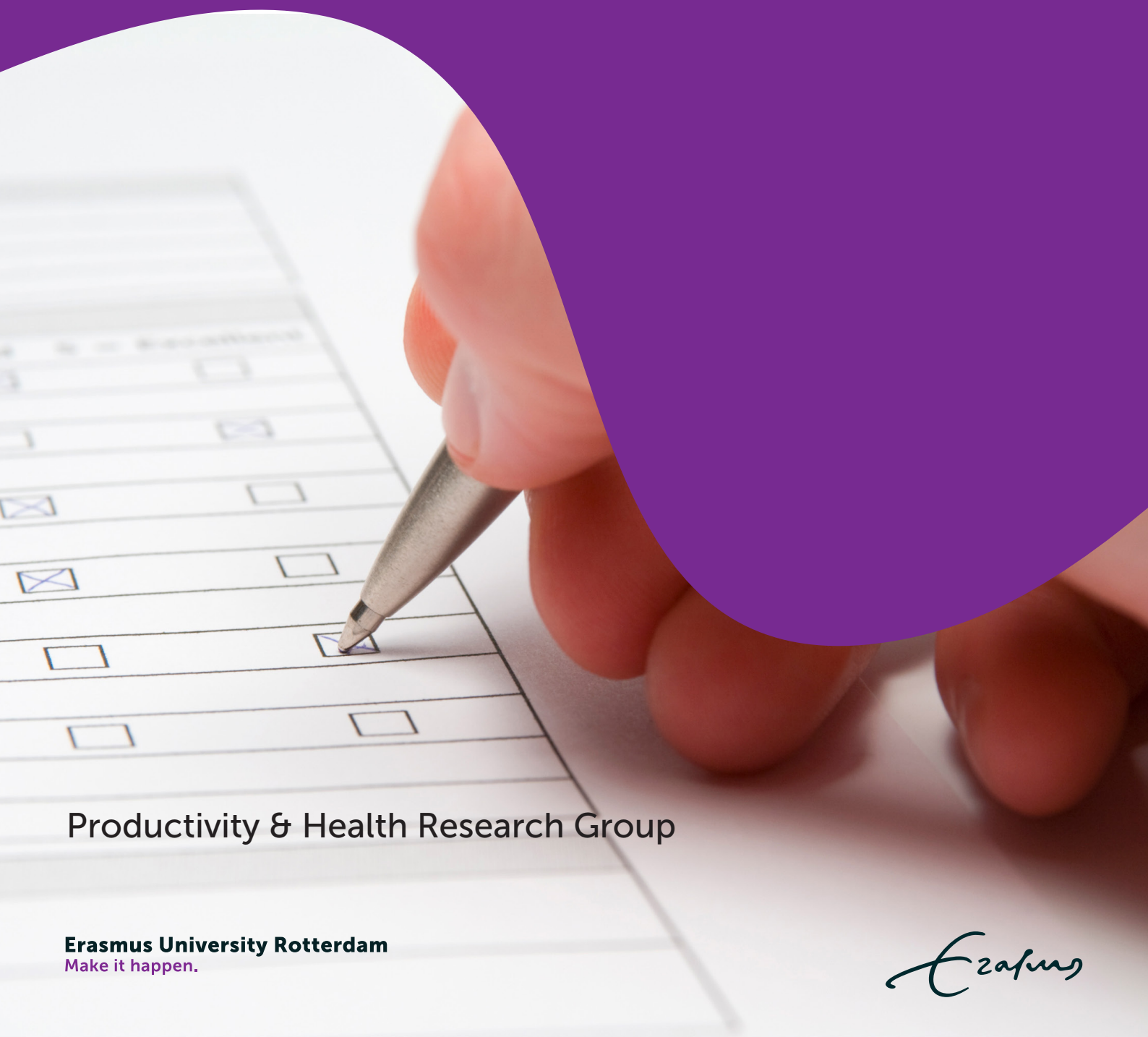


Medical Consumption Questionnaire Handleiding



Productivity & Health Research Group

HANDLEIDING

iMTA **Medical Consumption Questionnaire**

Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment
Erasmus Universiteit Rotterdam

Rotterdam, juli 2018



De iMCQ is in 2013 ontwikkeld door de *Productivity and Health Research Group*, bestaande uit Drs C Bouwmans, Dr L Hakkaart-van Roijen, Dr M Koopmanschap, Dr M Krol, Prof dr H Severens en Prof dr W Brouwer.

“Alle auteursrechten zijn en blijven voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt gewijzigd of vermenigvuldigd zonder toestemming van de auteurs. Deze toestemming is verkrijgbaar onder de voorwaarden zoals vermeld in de Gebruikersvoorwaarden.”

Inhoudsopgave

1 Inleiding.....	4
1.1 Achtergrond.....	4
1.2 Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de iMCQ	5
1.3 Steekproefgrootte, meetmomenten en recall-periode	6
1.4 Opbouw van de handleiding	7
2. Opbouw iMCQ.....	8
2.1 Algemeen.....	8
2.2 Vragen over medische consumptie.....	8
2.3 Andere kostencategorieën.....	10
3. Scoring en waardering.....	12
4. Gebruik van de iMCQ	13
4.1 Gebruikersvoorwaarden	13
5. Referenties.....	15
Bijlage I Vragenlijst iMCQ.....	16

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

In economische evaluaties van gezondheidszorg wordt onderzoek gedaan naar de kosten en de baten van medische interventies. Vanuit de Nederlandse richtlijnen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg wordt voorgeschreven dat een economische evaluatie dient uit te gaan van een 'maatschappelijk perspectief' (1). Het maatschappelijk perspectief houdt rekening met alle actoren in de samenleving; alle kosten moeten worden meegenomen, ongeacht wie de kosten draagt of de baten ontvangt. Bij de waardering van kosten in economische evaluaties wordt uitgegaan van het principe van opportunitetskosten. Het uitgangspunt hierbij is dat er sprake is van schaarse, alternatief aanwendbare middelen.

In de Nederlandse richtlijnen worden kosten onderverdeeld in drie categorieën: kosten binnen de gezondheidszorg, kosten van patiënten en familie en kosten in andere sectoren. In Tabel 1 wordt een aantal voorbeelden gegeven van kosten binnen de drie kostencategorieën. Het hanteren van een maatschappelijk perspectief impliceert dat alle kosten en baten dienen te worden meegenomen in een economische evaluatie. Dit betekent dat alle kosten in Tabel 1, wanneer relevant, dienen te worden geïncludeerd in een economische evaluatie.

Tabel 1. Voorbeelden van kostencategorieën in economische evaluaties.

Kosten binnen de gezondheidszorg	Kosten van patiënten en familie	Kosten in andere sectoren
Huisartsconsulten	Reiskosten	Productiviteitsverliezen
Paramedische zorg	Tijdkosten	Juridische kosten
Thuiszorg	Vitaminepreparaten	Speciaal onderwijs
Verpleegdagen	Medische hulpmiddelen	
Polikliniekbezoeken		
Ziekenhuisopnames		

De kosten binnen de gezondheidszorg zijn alle kosten die rechtstreeks verband houden met de preventie, diagnostiek, therapie, revalidatie en verzorging van een ziekte of aandoening. De Nederlandse richtlijnen bevelen aan om ook de zorgkosten in gewonnen levensjaren mee te nemen.

Kosten van patiënten en familie zijn bijvoorbeeld de tijd- en reiskosten van patiënten die direct samenhangen met de behandeling. Ook kosten van mantelzorg vallen in deze categorie.

Kosten in andere sectoren zijn onder andere productieverliezen als gevolg van afwezigheid of inefficiëntie tijdens betaald en onbetaald werk, juridische kosten en kosten van speciaal onderwijs.

In deze handleiding wordt een vragenlijst besproken die gebruikt wordt voor het verzamelen van data om de kosten binnen de gezondheidszorg te bepalen, de iMTA Medical Consumption Questionnaire (*iMCQ*).

1.2 Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de *iMCQ*

Voor het meten van de kosten in economische evaluaties wordt frequent gebruik gemaakt van vragenlijsten die door de patiënten, die in de studie zijn geïnccludeerd, zelf moeten worden ingevuld. Patiënten zijn de spin in het web van alle zorg die zij ontvangen en zijn daarom vaak een goede informatiebron. Met behulp van vragenlijsten kunnen volumegegevens van de diverse kostencomponenten van zorgconsumptie worden verzameld.

De *iMCQ* is een niet-ziekte specifieke vragenlijst die als doel heeft om de kosten binnen de gezondheidszorg te bepalen. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de *iMCQ* was om op een consistente en gestandaardiseerde manier informatie te verzamelen over de medische consumptie door middel van zelfrapportage. Standaardisatie heeft als doel om de vergelijkbaarheid tussen en generaliseerbaarheid van studies te vergroten. De vragenlijst is niet-ziekte specifiek. Hiermee wordt bedoeld dat er wordt gerefereerd aan zorgconsumptie als gevolg van 'gezondheidsproblemen'. Met 'gezondheidsproblemen' worden zowel lichamelijke als psychische klachten bedoeld. Onderscheid naar zorgconsumptie die gerelateerd is aan een specifieke behandeling of aandoening is voor de patiënt niet altijd eenduidig. Daarom wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een niet-ziekte specifieke vragenlijst.

De *iMCQ* is een basale vragenlijst en bevat een breed scala aan vragen over het zorggebruik van de patiënt. Vragen die niet relevant worden geacht voor de doelgroep kunnen worden weggelaten. De *iMCQ* kan ook worden aangevuld met items die relevant zijn voor bepaalde studiepopulaties. Voor het meten van medische consumptie van patiënten met psychische aandoeningen wordt het gebruik van de TIC-P aangeraden. In deze vragenlijst zijn behalve algemene contacten met de gezondheidszorg (extra) vragen opgenomen die betrekking hebben op contacten met specifieke hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De vragenlijst moet geschikt zijn voor zelfrapportage. Een van de voorwaarden voor de validiteit van een vragenlijst is de begrijpelijkheid van de vragen voor de patiënt. Om dit doel te bereiken is

een conceptversie van de vragenlijst voorgelegd aan medewerkers van Bureau Taal. Zij hebben de vragen omgezet in eenvoudige Nederlandse teksten (Taalniveau B1). Dat houdt in dat de teksten voor 95% van de mensen te begrijpen is; ook voor mensen met een laag opleidingsniveau. Ook hoger opgeleiden geven vaak de voorkeur aan teksten op een basaal niveau, omdat dit gemakkelijker en sneller leest. Een zogenaamde 'feasibility' studie is uitgevoerd om de consistentie en de begrijpelijkheid van de vragen te toetsen.

De vragen in de *i*MCQ zijn toegesneden op de Nederlandse organisatie van zorg. Hiermee moet rekening worden gehouden als overwogen wordt om de vragenlijst toe te passen voor internationale studies. De organisatie van zorg kan per land verschillen. Dit kan een belemmering vormen voor de generaliseerbaarheid van de resultaten naar andere landen.

1.3 Steekproefgrootte, meetmomenten en recall-periode

De minimale groepsgrootte en het aantal meetmomenten binnen een economische evaluatie hangt van een aantal zaken af. Voor de kosten is het benodigd aantal respondenten afhankelijk van de verwachte verschillen in medische kosten en kosten van productieverliezen tussen de experimentele groep en de controle groep. Daarnaast zullen behalve de kosten van ook andere effectmaten in een analyse worden meegenomen (zoals klinische effecten, kwaliteit van leven) die mede bepalend zijn voor het aantal respondenten dat minimaal moet worden geïncludeerd. Momenteel wordt de benodigde power van een kosteneffectiviteitanalyse (KEA) veelal bepaald door klinische effectmaten.

Bij de berekening van de kosten wordt verondersteld dat de tijdsperiode waarover gemeten wordt representatief is voor de gehele periode tussen twee meetmomenten. Zowel de optimale periode tussen twee meetmomenten, als het aantal metingen tijdens de looptijd van de studie en het aantal benodigde respondenten is afhankelijk van het verwachte verschil in kosten (en andere effectmaten), het verwachte verloop van de ziekte en de behandeling. In de standaardversie van de *i*MCQ wordt een recall-periode van 3 maanden gebruikt. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat een recall-periode van 3 maanden voor het meten van medische consumptie betrouwbare informatie genereert (2, 3).

Indien de periode tussen twee meetmomenten langer is, kunnen de gegevens door middel van extrapolatie worden aangepast aan het werkelijke tijdsverschil. Ook bestaat de mogelijkheid om de recall periode van de vragenlijsten uit te breiden. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met een verhoogde kans op fouten.

1.4 Opbouw van de handleiding

In hoofdstuk 2 wordt de algemene opbouw van de *i*MCQ. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de scoring en de waardering van medische consumptie. In hoofdstuk 4 vind u de gebruikersvoorwaarden.

De vragenlijst is opgenomen in Bijlage I.

2. Opbouw iMCQ

2.1 Algemeen

De iMCQ wordt voorafgegaan door een uitgebreide toelichting en instructie voor het invullen van de vragenlijst voor respondent. Desgewenst kan de onderzoeker de instructie aanpassen en/of relevante aanvullende informatie voor de respondent toevoegen. Aan het eind van de vragenlijst is ruimte voor opmerkingen van de respondent naar aanleiding van de vragen. De vragenlijst wordt afgesloten met een instructie voor het retourneren van de vragenlijst. Deze instructie moet door de onderzoeker worden aangevuld en/of worden aangepast.

Na de toelichting volgen 5 algemene vragen. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kan een beschrijving worden gegeven van de onderzoekspopulatie. Ook kunnen de antwoorden eventueel worden gebruikt voor subgroepsanalyses.

Behalve een vraag over de datum van het invullen van de vragenlijst betreffen de algemene vragen de leeftijd, het geslacht, het opleidingsniveau en de arbeidsstatus van de respondent.

Daarna volgen de vragen over de medische consumptie van de respondent. De vragenlijst is voorzien van een routing voor de respondent. Vragen die niet van toepassing zijn voor de respondent kunnen zo eenvoudig worden overgeslagen.

2.2 Vragen over medische consumptie

De medische consumptie wordt gemeten aan de hand van 18 vragen. Hierin zijn de volgende items van zorg opgenomen:

1^e lijnsvoorzieningen:

- ❖ Huisarts, inclusief POH
- ❖ Maatschappelijk werk(s)er
- ❖ Fysio- caesartherapeut/ therapeut Mensendieck/manueel therapeut
- ❖ Ergotherapeut
- ❖ Logopedist
- ❖ Dietist
- ❖ Homeopaat/acupuncturist
- ❖ Psycholoog/psychotherapeut/psychiater

- ❖ Bedrijfsarts
- ❖ Thuiszorg
- ❖ Gebruik van medicijnen

2e lijnsvoorzieningen:

- ❖ Spoedeisende eerst hulp
- ❖ Ambulance
- ❖ Poliklinische contacten
- ❖ Dagbehandeling (in ziekenhuis en andere instellingen)
- ❖ Opname (in ziekenhuis en andere instellingen)

De vraagstelling voor de verschillende zorg items is als volgt:

Hoeveel afspraken had u in de afgelopen 3 maanden met?

- ☐ Geen enkele afspraak
☐ afspraken

Bij een aantal zorg items wordt onderscheid gemaakt naar verschillende vormen van zorg. De respondent wordt d.m.v. een routing door deze vragen geloodst.

Vraag 10a. Heeft u in de afgelopen 3 maanden hulp van de thuiszorg gehad?

- ☐ Ja
☐ Nee

Heeft u "Ja" aangekruist? Beantwoord dan vraag 10b tot en met 10d.
 Ga anders verder met vraag 11.

De iMCQ is beperkt tot de meest voorkomende contacten met de zorg en/of zorgverleners. Vragen over vormen van zorg die niet relevant worden geacht voor de studiebevolking kunnen worden verwijderd. Ontbrekende vormen van zorg waarvan verwacht kan worden dat deze een

belangrijke bijdrage zullen leveren aan de totale kosten kunnen aan de vragenlijst worden toegevoegd. Hierbij moet steeds rekening worden gehouden met het feit dat ook de nummeringen van de vragen en de routing van de vragen moeten worden aangepast.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vragen over specifieke vormen van zorg uit te breiden om aanvullende informatie te verzamelen. Vanuit een kostenperspectief kan het bijvoorbeeld voor specifieke studiepopulaties, zoals patiënten met chronische aandoeningen, van belang zijn onderscheid te maken tussen type zorgverlener, zoals bij de contacten in een huisartspraktijk waarbij sprake kan zijn van o.a. contacten met een praktijkondersteuner, verpleegkundige of de huisarts.

2.3 Andere kostencategorieën

De iMCQ is ontwikkeld om de kosten binnen de gezondheidszorg te bepalen. In de Nederlandse richtlijnen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg wordt een maatschappelijk perspectief voorgeschreven.

2.3.1. Kosten van patiënten en familie

Voor een aantal studiepopulaties kunnen ook de kosten van mantelzorgers/ informele zorg een belangrijke bijdrage leveren aan de totale kosten. Voor die studiepopulaties, waarbij mantelzorg of informele zorg een belangrijk item is, wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de iMTA Valuation of Informal Care Questionnaire (iVICQ). De iVICQ heeft als doel om gedetailleerd informatie te verzamelen over het soort en de hoeveelheid mantelzorg. Daarnaast wordt informatie verzameld over de effecten hiervan op de mantelzorgers zelf. Meer informatie over de iVICQ en de waardering van mantelzorg is te vinden op de website van iMTA (www.imta.nl/questionnaires).

In een aantal gevallen zal het niet goed mogelijk zijn, bijv. vanwege praktische redenen, om data te verzamelen van de mantelzorgers zelf. Daarom kan aan de iMCQ een optionele vraag (vraag 19) worden toegevoegd indien verwacht wordt dat patiënten mantelzorg gebruiken. Het is aan de onderzoeker om te bepalen of deze vraag moet worden meegenomen.

Reiskosten kunnen een andere belangrijke kostenpost voor patiënten en familie zijn. In de iMCQ kan een optionele vraag (vraag 20) toegevoegd die reiskosten naar het ziekenhuis in kaart brengt. Het is aan de onderzoeker om te bepalen of deze vraag moet worden meegenomen.

2.3.2. Kosten in andere sectoren

Voor het bepalen van productiviteitsverliezen kan gebruik worden gemaakt van de iMTA Productivity Cost Questionnaire (iPCQ) (4). Beide vragenlijsten hebben een vergelijkbare structuur en vraagstellingen in eenvoudig Nederlands. De iMCQ kan daarom goed worden gecombineerd met de iPCQ. Meer informatie over de iPCQ is te vinden op de website van iMTA (www.imta.nl/questionnaires).

3. Scoring en waardering

De scoring voor de items die beginnen met 'Hoeveel afspraken had u ...' is als volgt. Het aantal afspraken dat de respondent vermeldt, wordt overgenomen. Wanneer de respondent heeft aangekruist 'Geen enkele afspraak' wordt een 0 ingevuld. Wanneer de respondent niets heeft aangekruist moet dit worden beschouwd als missende informatie.

Data met betrekking tot zorgitems waarin onderscheid wordt gemaakt naar verschillende typen zorg worden verzameld op basis van meerdere vragen. De eerste vraag over het betreffende item is steeds een selectievraag. Respondenten die 'Nee' aankruisen kunnen de volgende vragen overslaan en worden via de routing naar het volgende zorg item verwezen. Het antwoord 'Nee' wordt gescoord met een 2. De ontbrekende waardes voor vragen die overgeslagen mogen worden, worden gecodeerd als een terechte missing. Respondenten die 'Ja' antwoorden wordt gevraagd verder te gaan met de volgende vragen. Hierin wordt gevraagd naar een specificatie van het zorgitem en het aantal ontvangen zorg. Ontbrekende waardes van deze respondenten zijn onterechte missings.

Voor de waarderingen van de items zijn verschillende mogelijkheden, waaronder eigen kostprijsonderzoek en het gebruik van standaard kostprijzen (5). Hierbij heeft het gebruik van standaard kostprijzen vaak de voorkeur voor de vergelijkbaarheid van studies. Voor de waardering van de gebruikte medicatie wordt verwezen naar <http://www.medicijnkosten.nl>. Voor meer informatie over de waardering van de verschillende items van medische consumptie wordt verwezen naar de Handleiding voor onderzoek in de gezondheidszorg (5).

De kosten van de medische consumptie worden berekend door gemeten volumina van zorg te vermenigvuldigen met de kostprijs per eenheid zorg. Indien de periode waarin gemeten is representatief is voor een langere periode kan door middel van extrapolatie een berekening worden uitgevoerd voor een langere periode.

4. Gebruik van de iMCQ

De iMCQ kan zowel schriftelijk als mondeling worden afgenomen. De instructie die aan de vragenlijst voorafgaat en de instructie voor het retourneren van de vragenlijst moeten door de onderzoeker verder worden aangepast naar de specifieke context van uitvoering van het onderzoek.

4.1 Gebruikersvoorwaarden

De vragenlijst is ontwikkeld door het institute for Medical Technology Assessment (iMTA), Erasmus Universiteit Rotterdam en mag onder de volgende condities worden gebruikt:

- Voor het gebruik van de vragenlijst dient u **vooraf toestemming** te vragen. Een aanvraag voor het gebruik van de vragenlijst gebeurt door het online invullen van het registratieformulier dat te vinden is op de website van het iMTA (www.imta.nl/questionnaires). U ontvangt dan z.s.m. van ons een bericht. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming de vragenlijst te kopiëren en/of te verspreiden.
- Aan het gebruik van de iMCQ door wetenschappelijke instellingen zijn geen financiële consequenties verbonden. Voor onderzoek dat geheel of gedeeltelijk wordt gefinancierd door een commerciële organisatie wordt een licentiebedrag gerekend. Het licentiebedrag is afhankelijk van type studie, grootte van de populatie en duur van de studie en wordt bepaald op basis van informatie uit het registratieformulier. Toestemming wordt verleend na ontvangst van het licentiebedrag. Na registratie bent u niet verplicht tot aankoop.
- De notitie voor auteursrechten, welke op de titelpagina staat, dient overgenomen te worden in geval de vragenlijst ongewijzigd of grotendeel ongewijzigd wordt gebruikt. Indien de vragenlijst gewijzigd wordt, dient deze uitgave als **bronvermelding** te worden opgenomen.
- De bron dient als volgt expliciet in publicaties vermeld te worden:
www.imta.nl (iMTA Productivity and Health Research Group. Handleiding iMTA Medical Cost Questionnaire (iMCQ). Rotterdam: iMTA, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2018)
- Veranderingen in de vragenlijst mogen worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming. In de rapportage van de studie moet worden vermeld dat gebruik is gemaakt van een aangepaste versie van deze vragenlijst.

- Uitsluiting aansprakelijkheid: de gebruiker dient het institute voor Medical Technology Assessment (Erasmus Universiteit Rotterdam) en de auteurs van deze uitgave te vrijwaren voor schadeclaims van derden ontstaan door en/of gerelateerd aan het gebruik van deze uitgave door de gebruiker in geval van wijziging en/of vertaling of door fouten, weglatingen en misinterpretaties of enige consequenties hiervan.
- De gebruiker dient een referentie van manuscripten, artikelen of overige publicaties waarin resultaten van dit instrument worden vermeld aan de auteurs ter beschikking te stellen.

5. Referenties

1. Zorginstituut Nederland. Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de gezondheidszorg. Diemen, Nederland: Zorginstituut Nederland; 2016.
2. Van den Brink M, Van den Hout WB, Stiggelbout AM, Putter H, Van De Velde CJH, Kievit J. Self-reports of health-care utilization: diary or questionnaire? *Int J Technol Assess Health Care*. 2005;21(3):298-304.
3. Goossens ME, Rutten-van Molken MP, Vlaeyen JW, Van der Linden SM. The cost diary: a method to measure direct and indirect costs in cost-effectiveness research. *J Clin Epidemiol*. 2000;53(7):688-95.
4. Bouwmans C, Krol M, Severens H, Koopmanschap M, Brouwer W, Hakkaart-van Roijen L. The iMTA Productivity Cost Questionnaire: A Standardized Instrument for Measuring and Valuing Health-Related Productivity Losses. *Value Health*. 2015;18(6):753-8.
5. Hakkaart-van Roijen L, Van der Linden N, Bouwmans CAM, Kanter TA, Tan SS. Kostenhandleiding: Methodologie van kostenonderzoek en referentieprijzen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg. Diemen, Nederland: Zorginstituut Nederland; 2015.

Bijlage I Vragenlijst iMCQ

Vragenlijst over uw zorggebruik



Onderzoekers noemen deze vragenlijst de iMTA MCQ.

Versie juli 2018

Toelichting

Lees dit alstublieft eerst!

Voor wie is deze vragenlijst?

Deze vragenlijst is voor u. Er zijn verschillende mogelijkheden:

- U heeft de lijst van uw huisarts of in het ziekenhuis gekregen.
- U heeft de lijst per post gekregen en uw naam staat op de envelop.

Kunt u de lijst niet zelf invullen?

Als u de lijst niet zelf kunt invullen, kan iemand u misschien helpen. Bijvoorbeeld een familielid.

Waar gaat de vragenlijst over?

De vragenlijst gaat over uw zorggebruik in de afgelopen 3 maanden. We beginnen met algemene vragen. Bijvoorbeeld over uw geslacht en geboortedatum. Daarna stellen we vragen over uw zorggebruik.

Hoe lang duurt het om de lijst in te vullen?

Het duurt ongeveer 20 minuten om de lijst in te vullen.

Hoe moet u de lijst invullen?

- Begin bij de eerste vraag en volg de nummering.
- Kruis voor iedere vraag 1 hokje aan, behalve als er bij de vraag staat dat u meer dan 1 hokje mag aankruisen.
- Bij sommige vragen kunt u een getal of iets anders invullen op de stippellijn.
- U kunt geen foute antwoorden geven

Wilt u een antwoord veranderen?

- Streep het oude antwoord door.
- Kruis een nieuw antwoord aan.
- Zet een pijl voor het nieuwe antwoord.

☒ oud antwoord
→ ☒ nieuw antwoord

Wat gebeurt er met uw antwoorden?

Uw antwoorden worden gebruikt voor onderzoek. Alleen de onderzoekers zien uw antwoorden. Dus niemand anders.

De onderzoekers schrijven uw naam nergens op. En zij vertellen aan niemand dat u aan het onderzoek heeft meegewerkt.

Fijn dat u de lijst voor ons wilt invullen!

Algemene vragen

Vraag A1. Op welke datum vult u deze vragenlijst in?

dag		maand		jaar			

Vraag A2. Wat is uw geboortedatum?

dag		maand		jaar			

Vraag A3. Wat is uw geslacht?

- ☐ Man
☐ Vrouw

Vraag A4. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Zoek uw hoogste opleiding en kruis het hokje daarvoor aan.

- ☐ Ik heb geen school of opleiding afgemaakt
☐ Lagere school of basisschool
☐ Huishoudschool, vbo, lbo, lts, leao of lhno

☐ Mavo, mulo, ivo of vmbo
☐ Mbo, mts, meao, mhno, inas of intas
☐ Havo, vwo, hbs, mms, atheneum of gymnasium

☐ Hbo, hts, heao of hhno
☐ Universiteit
☐ Ik heb een andere opleiding afgemaakt, namelijk

.....

Vraag A5. Wat doet u in het dagelijks leven? Kruis aan wat u de meeste tijd doet.

- ☐ Ik zit op school, ik studeer
- ☐ Ik werk in loondienst
- ☐ Ik ben zelfstandig ondernemer
- ☐ Ik ben huisvrouw, huisman

- ☐ Ik ben werkloos
- ☐ Ik ben arbeidsongeschikt, voor ... %
- ☐ Ik ben met pensioen of prepensioen
- ☐ Ik doe iets anders, namelijk

.....

Vragen over zorggebruik

Toelichting

Wij willen graag weten met welke dokters u in de afgelopen 3 maanden een afspraak had. Het gaat om afspraken voor uzelf. Ook andere zorgverleners tellen mee. Bijvoorbeeld de fysiotherapeut.

Welke afspraken tellen mee?

- Controles
- Afspraken omdat u een lichamelijke of psychische klacht had
- Afspraken waarbij de dokter bij u thuis kwam
- Telefonische afspraken
- Telefoontjes met de receptenlijn

Wat telt niet mee?

- Afspraken voor een ander, bijvoorbeeld voor uw kind
- Telefoontjes om een afspraak te maken

Weet u niet precies hoeveel afspraken het waren? Schrijf dan op hoeveel het er ongeveer waren.

Vraag 1a. Heeft u in de afgelopen 3 maanden afspraken gehad met huisarts of praktijkondersteuner? Praktijkondersteuner wordt ook wel POH genoemd.

- ☐ Nee
☐ Ja

Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 1b.
Ga anders verder met vraag 2.

Vraag 1b. Hoeveel afspraken had u in de afgelopen 3 maanden met uw huisarts en/of praktijkondersteuner (POH)?

- ☐ afspraken huisarts
☐ afspraken praktijkondersteuner (POH)

Vraag 2. Hoeveel afspraken had u in de afgelopen 3 maanden met een maatschappelijk werker?

- ☐ Geen enkele afspraak
- ☐ afspraken

Vraag 3. Hoeveel afspraken had u in de afgelopen 3 maanden met een fysiotherapeut? Of met een caesartherapeut, therapeut mensendieck of een manueel therapeut? Tel alle afspraken met deze therapeuten bij elkaar op.

- ☐ Geen enkele afspraak
- ☐ afspraken

Vraag 4. Hoeveel afspraken had u in de afgelopen 3 maanden met een ergotherapeut?

- ☐ Geen enkele afspraak
- ☐ afspraken

Vraag 5. Hoeveel afspraken had u in de afgelopen 3 maanden met een logopedist?

- ☐ Geen enkele afspraak
- ☐ afspraken

Vraag 6. Hoeveel afspraken had u in de afgelopen 3 maanden met een diëtist?

- ☐ Geen enkele afspraak
- ☐ afspraken

Vraag 7. Hoeveel afspraken had u in de afgelopen 3 maanden met een homeopaat? Of met een acupuncturist? Tel alle afspraken met deze zorgverleners bij elkaar op.

- ☐ Geen enkele afspraak
- ☐ afspraken

Vraag 8. Hoeveel afspraken had u in de afgelopen 3 maanden met een psycholoog? Of met een psychotherapeut of psychiater? Tel alle afspraken met deze zorgverleners bij elkaar op.

- ☐ Geen enkele afspraak
- ☐ afspraken

Vraag 9. Hoeveel afspraken had u in de afgelopen 3 maanden met de bedrijfsarts?

- ☐ Geen enkele afspraak
- ☐ afspraken

Vraag 10a. Heeft u in de afgelopen 3 maanden hulp van de thuiszorg gehad?

- ☐ Nee
☐ Ja

Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 10b tot en met 10d.
Ga anders verder met vraag 11.

Vraag 10b. Wat voor hulp van de thuiszorg heeft u gehad in de afgelopen 3 maanden? U kunt meer dan 1 hokje aankruisen.

- ☐ Huishoudelijke hulp
voorbeeld: stofzuigen, bed opmaken, boodschappen doen
- ☐ Verzorging van uzelf
voorbeeld: hulp bij douchen of aankleden
- ☐ Verpleging
voorbeeld: verband omdoen, medicijnen geven, bloeddruk meten

Vraag 10c. Hoeveel weken heeft u deze thuiszorg gehad? Tel alle weken in de afgelopen 3 maanden bij elkaar op. *Let op: een periode van 3 maanden telt 13 weken.*

Huishoudelijke hulp: ... weken in de afgelopen 3 maanden

Verzorging van uzelf: ... weken in de afgelopen 3 maanden

Verpleging: ... weken in de afgelopen 3 maanden

Vraag 10d. Hoeveel uur thuiszorg kreeg u in deze weken gemiddeld?

Huishoudelijke hulp: gemiddeld ... uur in de week

Verzorging van uzelf: gemiddeld ... uur in de week

Verpleging: gemiddeld ... uur in de week

Vraag 11a. Heeft u in de afgelopen 3 maanden medicijnen gebruikt?

- ☐ Nee
☐ Ja

Heeft u “Ja” aangekruist? Vul dan bij vraag 11b in welke medicijnen en hoeveel.
Ga anders verder met vraag 12.

Vraag 11b. Welke medicijnen heeft u in de afgelopen 3 maanden gebruikt? Met medicijnen bedoelen we alle medicijnen die u hebt gekregen op recept en geneesmiddelen die u hebt gekocht bij de apotheek of de drogist. U ziet eerst drie voorbeelden.

Let op: pak de verpakking erbij! Daarop staat hoeveel u per keer moest nemen. En hoe vaak u dat moest doen. **Heeft u meer of minder gebruikt? Vul dan in hoeveel u ook echt gebruikt heeft.**

Hoe heet het medicijn?	Hoeveel heeft u per keer genomen? <i>Kijk op de verpakking</i>	Hoe vaak op een dag heeft u dit gedaan? <i>Kijk op de verpakking</i>	Op hoeveel dagen in de afgelopen 3 maanden heeft u het medicijn gebruikt?
<i>voorbeeld 1</i> Metoprolol (tegen hoge bloeddruk)	<i>voorbeeld</i> 100mg	<i>voorbeeld</i> 1 keer	<i>voorbeeld</i> 90 dagen
<i>voorbeeld 2</i> Furosemide (plastabletten)	<i>voorbeeld</i> 40 mg	<i>voorbeeld</i> 1 keer	<i>voorbeeld</i> 26 dagen (2 x per week; 13 weken)
<i>voorbeeld 3</i> Hydrocortison crème	<i>voorbeeld</i> -	<i>voorbeeld</i> 1	<i>voorbeeld</i> 14 dagen
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

Vraag 12. Hoe vaak bent u in de afgelopen 3 maanden op de spoedeisende eerste hulp van een ziekenhuis geweest? Een andere naam voor spoedeisende eerste hulp is EHBO.

- ☐ Geen enkele keer
- ☐ ... keer

Vraag 13. Hoe vaak bent u in de afgelopen 3 maanden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht? Een andere naam voor ambulance is ziekenauto.

- ☐ Geen enkele keer
- ☐ ... keer

Vraag 14a. Had u in de afgelopen 3 maanden een afspraak bij de polikliniek van het ziekenhuis? Het gaat om afspraken voor uzelf met een dokter. Bijvoorbeeld met de cardioloog, reumatoloog of neuroloog.

- ☐ Nee
- ☐ Ja

Heeft u “Ja” aangekruist? Vul dan bij vraag 14b in bij welke soorten dokters u geweest bent. En hoe vaak. Op de eerste rij staat een voorbeeld.
Ga anders verder met vraag 15.

Vraag 14b. Bij welke soorten dokters bent u in de afgelopen 3 maanden in het ziekenhuis geweest? En hoe vaak?

<i>Bij welke soort dokter bent u in het ziekenhuis geweest?</i>	<i>Hoe vaak bent u in de afgelopen 3 maanden bij deze dokter geweest?</i>
<i>voorbeeld</i> cardioloog	<i>voorbeeld</i> 2 keer
.....	... keer
.....	... keer
.....	... keer
.....	... keer
.....	... keer
.....	... keer
.....	... keer

Vraag 15a. Bent u in de afgelopen 3 maanden overdag in het ziekenhuis geweest voor een behandeling? U bleef dus niet slapen. U kwam bijvoorbeeld voor een bloedtransfusie, nierdialyse of chemokuur.

- ☐ Nee
☐ Ja

Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 15b en 15c.
Ga anders verder met vraag 16.

Vraag 15b. Voor welke soort behandeling was dit? Was dit voor meer dan 1 soort behandeling? Vul dan alle soorten behandelingen in.

Behandeling 1:

Behandeling 2:

Behandeling 3:

Vraag 15c. Hoeveel keer moest u in de afgelopen 3 maanden voor deze behandelingen naar het ziekenhuis?

..... keer voor behandeling 1

..... keer voor behandeling 2

..... keer voor behandeling 3

Vraag 16a. Bent u in de afgelopen 3 maanden ergens anders geweest voor een behandeling overdag? U bleef dus niet slapen. U ging bijvoorbeeld naar de dagopvang van een woon-/zorgcentrum of een psychiatrische instelling. Of naar de dagbehandeling van een revalidatiecentrum.

☐ Nee

☐ Ja

Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 16b en 16c.
Ga anders verder met vraag 17.

Vraag 16b. Wat voor instelling was dit? Kruis het goede antwoord aan. U kunt meer dan 1 hokje aankruisen.

☐ Woon-/zorgcentrum

☐ Revalidatiecentrum

☐ Psychiatrische instelling

☐ Een andere instelling, namelijk

.....

Vraag 16c. Hoe vaak moest u hier in de afgelopen 3 maanden naartoe? Heeft u bij vraag 16b meer dan 1 hokje aangekruist? Vul dan hieronder voor iedere instelling in hoe vaak u er bent geweest.

Naar het woon-/zorgcentrum: keer in de afgelopen 3 maanden

Naar het revalidatiecentrum: keer in de afgelopen 3 maanden

Naar de psychiatrische instelling: keer in de afgelopen 3 maanden

Naar de andere instelling: keer in de afgelopen 3 maanden

Vraag 17a. Heeft u in de afgelopen 3 maanden weleens in het ziekenhuis gelegen?

U moest dus blijven slapen. Bijvoorbeeld omdat u geopereerd was en niet meteen naar huis kon.

☐ Nee

☐ Ja

Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 17b en 17c.

Ga anders verder met vraag 18.

Vraag 17b. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 3 maanden in het ziekenhuis gelegen?

..... keer in de afgelopen 3 maanden

Vraag 17c. Hoe lang heeft u in het ziekenhuis gelegen? Heeft u meer dan 1 keer in het ziekenhuis gelegen in de afgelopen 3 maanden? Tel dan alle dagen bij elkaar op.

..... dagen in totaal in de afgelopen 3 maanden

Vraag 18a. Moest u in de afgelopen 3 maanden ergens anders blijven slapen voor uw gezondheid? Bijvoorbeeld in een woon-/zorgcentrum, psychiatrische instelling of revalidatiecentrum.

- ☐ Nee
☐ Ja

Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 18b en 18c.
Ga anders naar het einde van de vragenlijst.

Vraag 18b. Wat voor instelling was dit? U kunt meer dan 1 hokje aankruisen.

- ☐ Woon-/zorgcentrum
☐ Revalidatiecentrum
☐ Psychiatrische instelling
☐ Een andere instelling, namelijk

.....

Vraag 18c. Hoe lang bent u in deze instelling geweest? Heeft u bij vraag 18b meer dan 1 hokje aangekruist? Vul dan hieronder voor iedere instelling in hoe lang u er bent geweest.

Bent u ergens meer dan 1 keer geweest in de afgelopen 3 maanden? Tel dan alle dagen bij elkaar op.

In het woon-/zorgcentrum: dagen in de afgelopen 3 maanden

In het revalidatiecentrum: dagen in de afgelopen 3 maanden

In de psychiatrische instelling: dagen in de afgelopen 3 maanden

In de andere instelling: dagen in de afgelopen 3 maanden

Dit was de laatste vraag.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Misschien heeft u nog vragen of opmerkingen? Schrijft u deze dan hieronder op.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wat moet u doen met de ingevulde vragenlijst?

Heeft u alles ingevuld? Doe de vragenlijst dan in de envelop. Er hoeft geen postzegel op. Doe de envelop alstublieft snel op de post. In elk geval vóór xxx.

Bent u de envelop kwijtgeraakt? Dan kunt u de vragenlijst in een andere envelop zonder postzegel sturen naar:

xxx

xxx

xxx

Hartelijk dank!

Optionele vragen

Voor de onderzoeker: vraag 19 en 20 kunt u aan de vragenlijst toevoegen indien u kosten van patiënten en familie wilt meten in een maatschappelijk perspectief. Doe dit alleen als deze vragen relevant zijn!

Vraag 19a. Heeft u in de afgelopen 3 maanden hulp gekregen van een familielid of een bekende vanwege uw lichamelijke of psychische problemen?

- ☐ Nee
☐ Ja

Heeft u “Ja” aangekruist? Beantwoord dan vraag 19b tot en met 19d.
Ga anders verder met vraag 20.

Vraag 19b. Wat voor hulp van familieleden of bekenden heeft u gehad in de afgelopen 3 maanden? U kunt meer dan 1 hokje aankruisen.

- ☐ Huishoudelijke hulp
voorbeeld: stofzuigen, bed opmaken, boodschappen doen, klaarmaken van eten en drinken, verzorgen van kinderen
- ☐ Verzorging van uzelf
voorbeeld: hulp bij douchen of aankleden, hulp bij het eten en drinken of het geven van medicijnen
- ☐ Praktische hulp
voorbeeld: ondersteuning bij wandelen, het maken van uitstapjes of bezoeken aan bekenden, bezoeken aan de huisarts of het ziekenhuis, het regelen van hulp of het regelen van financiële zaken

Vraag 19c. Hoeveel weken heeft u deze hulp gehad? Tel alle weken in de afgelopen 3 maanden bij elkaar op. *Let op: een periode van 3 maanden telt 13 weken.*

Huishoudelijke hulp: ... weken in de afgelopen 3 maanden

Verzorging van uzelf: ... weken in de afgelopen 3 maanden

Praktische hulp: ... weken in de afgelopen 3 maanden

Vraag 19d. Hoeveel uur hulp kreeg u in deze weken gemiddeld?

Huishoudelijke hulp: gemiddeld ... uur in de week

Verzorging van uzelf: gemiddeld ... uur in de week

Praktische hulp: gemiddeld ... uur in de week

Vraag 20a. Welke wijze van vervoer heeft u gebruikt om van huis naar het ziekenhuis te gaan?

- ☐ Niet van toepassing
- ☐ Te voet
- ☐ Fiets
- ☐ Auto

- ☐ Openbaar vervoer
- ☐ Taxi
- ☐ Anders, namelijk

.....

Vraag 20b. Wat was de enkele reisafstand tussen uw huis en het ziekenhuis?

Deze afstand bedroeg: kilometer